

Bronchial Asthma (الربو الشعبي)

Definition (التعريف)

Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways causing airway sensitivity, swelling, and mucus production.

الربو هو مرض التهابي مزمن في الشعب الهوائية يسبب زيادة الحساسية، وتورم الممرات الهوائية، وإنتاج المخاط.

It is the most common chronic disease in children but can occur at any age.

يُعد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا بين الأطفال، لكنه يمكن أن يحدث في أي عمر.

Asthma affects daily life, including school, work, activity, and quality of life.

يؤثر الربو على الحياة اليومية مثل الدراسة، العمل، النشاط البدني، وجودة الحياة.

Causes (الأسباب)

Allergy is the strongest predisposing factor for asthma.

الحساسية هي أهم عامل يؤدي للإصابة بالربو.

Chronic exposure to irritants or allergens increases asthma risk.

التعرض المستمر للمهيجات أو مسببات الحساسية يزيد خطر الإصابة بالربو.

Common allergens may be:

- **Seasonal:** grass, tree, and weed pollens.
- **Perennial:** dust, animal dander.
مسببات الحساسية الشائعة تشمل:
- موسمية: حبوب لقاح الأشجار والأعشاب.
- دائمة: الغبار وشعر الحيوانات.

Triggers include air pollution, cold or hot weather, weather changes, strong odors, perfumes, and smoke.

من المثيرات الشائعة: تلوث الهواء، البرد أو الحر، تغير الطقس، الروائح القوية، والعطور والدخان.

Most people with asthma are sensitive to many triggers.

أغلب المصابين بالربو حساسون لعدة مثيرات في نفس الوقت.

Pathophysiology (الفيزيولوجيا المرضية)

Asthma causes reversible airway inflammation leading to airway narrowing.

يسبب الربو التهابًا قابلاً للعكس في الشعب الهوائية يؤدي لتضييقها.

Mast cells release mediators such as histamine, prostaglandins, and leukotrienes.

تفرز الخلايا البدينة مواد كيميائية مثل الهيستامين والبروستاغلاندين واللوكوترايين.

These chemicals increase blood flow, swelling, and cause bronchoconstriction.

تؤدي هذه المواد إلى زيادة تدفق الدم، التورم، وتضيق الشعب الهوائية.

Clinical Manifestations (الأعراض السريرية)

1. Cough (especially at night).

السعال (خصوصًا أثناء الليل).

2. Dyspnea (shortness of breath).

ضيق التنفس.

3. Wheezing (whistling sound during breathing).

صفير في الصدر أثناء التنفس.

4. Asthma exacerbation (acute attack).

نوبة ربو حادة.

Assessment and Diagnostic Findings (التقييم والتشخيص)

Episodic symptoms of airflow obstruction are assessed.

يتم تقييم وجود أعراض انسداد متكرر في تدفق الهواء

Family history and environmental exposure (cold air, pollution) are important.

تاريخ العائلة والعوامل البيئية مثل الهواء البارد والتلوث مهمة في التشخيص

Comorbid conditions include GERD and drug-induced asthma.

قد ترافق الربو أمراض أخرى مثل الارتجاع المريئي أو الربو الناتج عن الأدوية

Sputum and blood tests are performed.

يتم إجراء تحاليل البلغم والدم

Serum IgE levels may increase if allergy is present.

في الدم في حالة وجود حساسية IgE ترتفع مستويات

Arterial blood gases and pulse oximetry check oxygen levels.

تحليل غازات الدم ومقياس الأكسجين لتقييم مستوى الأكسجين

Complications (المضاعفات)

Respiratory failure — فشل تنفسي

Pneumonia — التهاب رئوي

Atelectasis — انخماص أو انهيار جزء من الرئة

Medical Management (العلاج الطبي)

Immediate medical help may be needed in severe cases.

قد تحتاج الحالات الشديدة إلى تدخل طبي فوري

Pharmacologic Therapy (العلاج الدوائي)

1. Quick Relief Medications (أدوية سريعة المفعول):

Short-acting beta2 agonists (Ventolin) are first choice for acute symptoms.

منبهات بيتا 2 قصيرة المفعول (فنتولين) هي الخيار الأول لتخفيف الأعراض الحادة.

Anticholinergics (Atrovent) can be used if beta2 drugs are not tolerated.

يمكن استخدام مضادات الكولين (أتروفنت) إذا لم يتحمل المريض أدوية بيتا 2.

2. Long-Acting Control Medications (أدوية طويلة المفعول):

Corticosteroids are the most effective anti-inflammatory drugs.

الكورتيكوستيرويدات هي أكثر الأدوية فعالية ضد الالتهاب.

Inhaled form is preferred; rinse mouth after use to prevent oral thrush.

يُستخدم الشكل المستنشق ويفضل غسل الفم بعد الاستخدام لتجنب الفطريات.

Long-acting beta2 agonists (Salmeterol) last up to 12 hours and are used with corticosteroids.

منبهات بيتا 2 طويلة المفعول (مثل سالميتيرول) تستمر حتى 12 ساعة وتُستخدم مع الكورتيكوستيرويدات للتحكم الطويل.

☑ Management of Exacerbations (علاج النوبات الحادة):

Early treatment and patient education are key.

العلاج المبكر وتثقيف المريض هما الأساس.

Teach self-management for patients with frequent or severe attacks.

يجب تعليم المريض كيفية إدارة حالته بنفسه خاصة إذا كانت النوبات متكررة أو شديدة.

Oxygen may be needed to relieve low oxygen levels (hypoxemia).

قد يحتاج المريض إلى أكسجين لعلاج نقص الأكسجة.

Antibiotics are used if infection or fever is present.

تُستخدم المضادات الحيوية عند وجود عدوى أو حمى.

Peak Flow Monitoring (مراقبة تدفق الهواء):

Daily peak flow monitoring helps control asthma.

المتابعة اليومية لتدفق الهواء تساعد في السيطرة على الربو.

Recommended for patients with moderate to severe or worsening symptoms.

يُنصح بها للمرضى المصابين بالربو المتوسط أو الشديد أو عند تدهور الأعراض.

Patient must learn proper technique and use maximal effort.

يجب على المريض تعلم الطريقة الصحيحة وبذل أقصى جهد أثناء القياس.

Nursing Management (العناية التمريضية)

Nursing care depends on symptom severity.

تعتمد الرعاية التمريضية على شدة الأعراض.

Mild cases may be treated at home; severe cases may require hospitalization.

يمكن علاج الحالات الخفيفة في المنزل، أما الحالات الحادة فقد تحتاج للمستشفى.

Keep a calm approach to reduce patient anxiety.

يجب التعامل بهدوء لطمأنة المريض وتقليل القلق.

Assess breathing, breath sounds, oxygen levels, and vital signs.

تقييم التنفس، وأصوات الصدر، ومستوى الأكسجين، والعلامات الحيوية.

Check for allergies before giving medications.

يجب التأكد من عدم وجود حساسية قبل إعطاء الأدوية.

Give fluids if dehydrated.

إعطاء سوائل للمريض إذا كان يعاني من الجفاف.

Assist in intubation and monitor closely if needed.

تساعد الممرضة في التنبيب ومراقبة المريض بدقة عند الحاجة.

